基本检查与总原则

斜视诊疗指南 · 2026 指南

基本病史与检查

记录起病、恒定 / 间歇、复视 / 头位、远近变化和控制；询问儿童围产史及获得性斜视神经 / 眶病 / 外伤 / 全身病。检查远近视力、外眼 / 前节 / 眼底 / 眼压。

2026 PDF1–2

眼位与双眼视

遮盖 / 三棱镜定量，远距 5 或 6 m ，近用调节视标；九诊断眼位、运动、 Worth/Bagolini/ 远近立体视。疑麻痹 / 限制时牵拉 / 收缩试验及按需影像。

2026 PDF2–3 、 19–20

共同治疗原则

先矫正屈光不正和治疗弱视；手术时机综合类型、斜视稳定性、年龄、双眼视、复视与全身情况。无症状隐斜一般不干预。

2026 PDF3–4

剂量、单位与阈值均按本篇原文；未列推荐等级者原文未明确。详细来源及缺项见提取表。

验光与内斜视分支

斜视诊疗指南 · 2026 指南

儿童散瞳验光

6 岁以上且无内斜，初验可 1.0% 环喷托酯；残余调节 / 不稳改 1.0% 阿托品眼膏或凝胶。内斜一般 1% 阿托品；≥ 12 岁且无调节相关异常可酌用复方托吡卡胺。

2026 PDF2

先天内斜

生后 6 个月内持续内斜；通常 >40△ 。 <4 月龄间歇、可变或 <40△ 密切随访。验光 <+2.00 DS 可不配镜，≥+2.00 DS 戴镜观察 3 ～ 6 月；建议 24 月龄前手术。

2026 PDF4–5

屈光调节性内斜

1% 阿托品验光后远视足矫，有弱视行遮盖； 5 岁前每 6 月复查验光 / 眼位 / 矫正视力， 5 岁后每年。转部分调节或合并垂直斜尽早手术。

2026 PDF5–6

剂量、单位与阈值均按本篇原文；未列推荐等级者原文未明确。详细来源及缺项见提取表。

调节相关与急性内斜

斜视诊疗指南 · 2026 指南

高 AC/A 及部分调节性

高 AC/A：视近内斜视度大于视远 10△、AC/A>6:1；双焦点远视足矫，近附加 +1.50 ～ +3.00 DS。部分调节：全矫后残余内斜 >10△，治弱视后手术残余角。

2026 PDF6–7

急性内斜与术后异常

急性共同性内斜首先完善神经 / 影像排除颅内器质病；外斜术后内斜伴明显复视及严重外转受限，警惕肌肉滑脱、及时探查。

2026 PDF7–8

缺项与原文边界

无统一正式推荐等级、跨类型手术量表、所有药物剂量 / 禁忌或单一危险评分；间歇外斜远近差 10 ～ <15△ 的分类边界未单独说明，不补编。

2026 PDF9–10、20–21

剂量、单位与阈值均按本篇原文；未列推荐等级者原文未明确。详细来源及缺项见提取表。

外斜分型与手术时机

斜视诊疗指南 · 2026 指南

间歇外斜分型

基本型远近差 <10△；分开过强型：远距斜视度较近距大，差值≥ 15△，遮盖一眼 30 ～ 60 min 仍大；集合不足型：近距斜视度较远距大，差值≥ 15△；类似分开过强型遮盖后近角增大。

2026 PDF9–10

间歇外斜决策

控制良好可观察立体视；频发、评分升高、每日较长时间外斜、近立体下降 / 远立体丧失 / 融合范围减少 → 考虑手术。未给统一评分手术切点。

2026 PDF10

先天 / 恒定外斜

先天外斜推荐 12 ～ 18 月龄手术，不稳可延至 18 ～ 24 月龄；先矫屈光 / 治弱视。恒定外斜以手术为主，可交替注视者及时手术。

2026 PDF9–10

剂量、单位与阈值均按本篇原文；未列推荐等级者原文未明确。详细来源及缺项见提取表。

A-V 、麻痹及特殊病因

A-V 与集合不足

V 型上 / 下转差≥ 15△， A 型差≥ 10△；结合斜肌功能决定手术。集合不足近点 >6 cm ，先集合训练 / 棱镜，症状重且无效可考虑手术。

2026 PDF11–12

麻痹 / 限制性路径

先找病因并处理原发病，必要影像；未稳用遮盖 /Fresnel 棱镜 / 肉毒毒素。多数待斜视度稳定约 6 月手术；肌断裂 / 眶嵌顿等急诊可早期介入。

2026 PDF7 、 11 、 13–14

特殊病因与慎用

Duane 第一眼位无斜及代偿头位无需治，有则手术、慎加强； Brown 查因后 3 ～ 6 月保守无效再考虑手术；甲状腺眼病联合内分泌，不能仅调眼位。

2026 PDF15–17

其他特殊类型与手术检查

斜视诊疗指南 · 2026 指南

其他病因提示

松眼 / 重眼可行 MRI 评估；重眼通常需手术且先查视网膜。重症肌无力以神经内科治疗为主，全身良好、无危象、症状及角度稳定 6 ～ 12 月才慎重手术。

2026 PDF12–13 、 18

手术前评估

九眼位定量、双眼视、按需 CT/MRI/ 超声；麻醉诱导后、切口前牵拉试验。按年龄 / 麻醉 / 疾病做全身检查；儿童全麻需麻醉评估及儿科会诊。

2026 PDF19–20

罕见类型补充

DVD 合并水平斜视时一眼同次一般不超两条直肌（显微血管分离可三条）；纤维化手术改善眼 / 头位不能恢复运动； Moebius 可手术；中枢麻痹先治原发病。

2026 PDF14–16 、 18

剂量、单位与阈值均按本篇原文；未列推荐等级者原文未明确。详细来源及缺项见提取表。

围术期用药与长期随访

斜视诊疗指南 · 2026 指南

术前预防用药

本 2026 指南规定术前 3 日预防性抗生素滴眼液，每日 3 ～ 4 次；具体品种和每次滴数原文未明确。与 2025 儿童共识的表述分开保存。

2026 PDF20

麻醉与术后管理

<12 岁通常全麻；≥ 12 岁按配合 / 复杂性及意愿选择。术后常规抗生素，按炎症联合 NSAID/ 激素；具体统一剂量与禁忌清单未明确。

2026 PDF20–21

规律长期随访

术后 1 天、 1 周、 1 月、 3 月、 6 月；后按恢复每 6 ～ 12 月一次，持续至视觉发育成熟，即使早期眼位良好也不终止。

2026 PDF21

剂量、单位与阈值均按本篇原文；未列推荐等级者原文未明确。详细来源及缺项见提取表。

一页流程｜斜视诊疗指南

判断条件与下一步 · 按本篇原文整理 · 2026

1 病史、眼位、视力与屈光

全面眼检查 / 双眼视；儿童睫状肌麻痹验光；急性 / 非共同或外伤 → 先病因与必要神经 / 眶影像。

2026 PDF1–3 、 7–8 、 11 、 13–14 、 19–20

2 先屈光与弱视处理

足矫及弱视治疗后，重新测量远近角和控制 / 立体视，再按内 / 外 / 特殊分支决策。

2026 PDF3–7

3 内斜分支

全矫正位→调节性；残余 >10△→ 部分调节性评估手术；高 AC/A >6:1→ 双焦点等；先天按年龄时机。

2026 PDF4–7

4 外斜分支

控制良好→观察；频率 / 评分恶化或立体视下降→考虑手术；恒定 / 先天按对应时机。

2026 PDF9–10

5 麻痹 / 特殊分支

病因治疗；一般角度稳定约 6 月再手术；眶嵌顿 / 肌断裂等可早介入；各综合征见专门条目。

2026 PDF7 、 11–19

6 围术期与长期复查

按 2026 术前方案；术后第 1 天、第 1 周、第 1 、 3 、 6 个月，此后每 6 ～ 12 个月；术后异常受限 + 复视及时排滑脱。

2026 PDF7–8 、 19–21

流程为整理表达；原文未明确的切点、剂量或等级不补编。完整证据与特殊分支见提取表。